

MENINGITE A LIQUIDE CLAIR

Pr N. BOULAKEHAL

SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES

CHU de Constantine

OBJETIFS PEDAGOGIQUES

1. Diagnostiquer une méningite à liquide clair
2. Identifier les situations nécessitant un traitement d'urgence
3. Enumérer les principales étiologies

Plan du cours

- Introduction
- Diagnostic d'une méningite à liquide clair
- Diagnostic étiologique et traitement
 - Méningite décapitée
 - Méningites lymphocytaires normoglycorachiques
 - Méningites lymphocytaires hypoglycorachiques
- Conclusion

INTRODUCTION

- Les méningites à liquide clair posent avant tout un **problème étiologique**, si la majorité d'entre elles de nature **virale** et d'évolution bénigne, il impose au plutôt d'en reconnaître **les causes qui nécessite un traitement urgent**.

Diagnostic positif

1. **Clinique** : syndrome méningé fébrile voir cours méningites purulentes.
2. **Biologique** : LCS clair, hypercellularité > 10 elts/mm³
LCS, normo ou hypoglycorachie, normo ou hyperprotéinorachie

Diagnostic étiologique et traitement

Démarche étiologique

Interrogatoire :

- Mode d'installation
- Survenue récente d'une maladie infectieuse: parotidite, éruption, infection ORL, diarrhée
- Prise d'antibiotique
- Contage tuberculeux

Examen neurologique complet:

- neurologique: conscience, déficit focalisé, hypertension intracrânienne
- infectieux : maladie éruptive en cours ou débutante; parotidite
- oculaire: stase papillaire, paralysie oculomotrice.
- généraux: hépato-splénomégalie, adénopathies, signes respiratoires

Diagnostic étiologique et traitement

■ Examen du LCS :

- Numération et formule leucocytaire - protéinorachie - Glycorachie, lactates
- Ex direct , Culture : systématique
- recherche d'Ag solubles,
- Si forte suspicion de TBC : ex direct par coloration de Ziehl -Neelsen et culture sur milieu Lowenstein Jensen, PCR BK
- Absence d'argument en faveur de méningite bactérienne PCR entérovirus, HSV, selon la situation CMV, VZV, VIH...
- Si ID : recherche de cryptocoque coloration à l'encre de chine pour ex direct , Ag sang et LCS, culture

Autres examens: en fonction de l'orientation étiologique : NFS,CRP, procalcitonine, hémocultures, ionogramme sanguin , glycémie, RX thorax, IDR ;EEG , scanner/IRM.

Diagnostic étiologique et traitement

A. Prédominance PNN, Hypoglycorachie, hyperprotéinorachie,

1. Bactérienne décapitée : ex direct et culture négatifs , ANTD d'antibiothérapie traversant la barrière hémoméningée.
2. Méningite bactérienne (méningo, pneumo, Hib) à son début

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques

- Protéinorachie normale ou discrètement augmentée
- méningites lymphocytaires aiguës
- Virus +++, adulte jeune ,enfant

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques

1. **Virales+++** : diagnostic repose sur des arguments épidémiologiques, cliniques et biologiques.

- Syndrome méningé est franc, début brutal, examen neurologique est souvent normal, état de conscience est généralement conservé.
- Signes extra-méningés : ADP, SPM, éruption cutanée, arthralgies, myalgies, parotidite, signes digestifs.

Ces signes orientent vers le type de virus.

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques

1. Virales

- **Entérovirus** : 90% des cas, cas sporadiques, épidémies estivales, parfois prodromes digestifs
- **Oreillons** : contagé , parotidite , absence de vaccination
- **Varicelles /zona**: éruption vésiculeuse
- **Primoinfection VIH**: comportement sexuel à risque, rapport sexuel non protégé
- **HSV1, HSV2, CMV, EBV**: syndrome mononucléosique

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques

1. Virales

- **LCS** : Hypercytose, Protéinorachie normale ou modérément élevée, Glycorachie normale ou modérément diminuée.
- **Examens virologiques** : PCR entérovirus et HSV dans le LCS, PCR ARN VIH ou antigénémie P24 si suspicion de primo-infection VIH en cas de facteurs de risque sexuel

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques

1. Virales

- **Evolution** : guérison sans séquelles sauf risque de surdité en cas de **méningite ourlienne** et **méningo-encéphalite herpétique** dont le pronostic est grave

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques

1. Virales

- Traitement symptomatique
- Infection VIH : Trt antirétroviral, trithérapie
- Aciclovir en cas de **méningoencéphalite** à HSV1 et VZV Acyclovir IV 10-15 mg/kg/8h, Pdt 14 – 21 j
- Aciclovir : pas d'intérêt dans les méningites HSV et VZV

Diagnostic étiologique et traitement

B. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques :

2. bactérienne

➤ Méningite des leptospiroses :

- Elles sont fréquentes, surtout en période estivo-automnale.
- Diagnostic facile : atteinte hépatique, atteinte rénale, infection conjonctivale et myalgies.
- Diagnostic : mise en évidence des leptospires dans le sang et LCS, **diagnostic sérologique.**

Diagnostic étiologique et traitement

A. Méningites lymphocytaires normoglycorachiques :

➤ Autres:

- **syphilis, maladie de lyme** : méningoencéphalite
- **brucellose**
- **Parasitaires et mycosiques** : elles sont rares
 - Forme neuro-méningé du paludisme à *P. falciparum*.
 - Toxoplasmose congénitale ou acquise chez l'immunodéprimé.
 - Méningite mycosique : surtout à *cryptococcus neoformans* chez l. déprimé (SIDA).

Diagnostic étiologique et traitement

C. Méningites lymphocytaires hypoglycorachiques

1. Tuberculeuse :

- Fréquente dans notre pays.
- Notion de contagé tuberculeux
- Début progressif.
- Signes méningés au second plan par rapport aux signes généraux et neurologiques de focalisations , état fébrile, altération de l'état général, asthénie, anorexie, troubles psychiques, strabisme, diplopie hémiparésie.

Diagnostic étiologique et traitement

C. Méningites lymphocytaires hypoglycorachiques

1. Tuberculeuse :

- LCS : hypercytose, hyperprotéinorachie, Hypoglycorachie, hypochlorurachie.
- Examen paraclinique: hyponatrémie(sécrétion inappropriée ADH), IDR, Radiographie pulmonaire : miliaire tuberculeuse, F.O (tubercule de bouchut).
- Diagnostic confirmé par la m.e.v. du B.a.a.r dans le LCS à l'examen direct du fait de la coloration par la technique de Ziel-Neelsen ou à la culture sur milieu de lowenstein-jensen
- Gene Xpert MTB RIF : permet de détecter le BK et la résistance à la rifampicine en moins de 2heures

Diagnostic étiologique et traitement

C. Méningites lymphocytaires hypoglycorachiques

1. Tuberculeuse :

- quadruple RHZE pendant 02 mois/RH pendant 12 mois.
- Corticothérapie:

dexaméthasone IV/PO

- Enfant : **0,6 mg/kg/j** pendant 4 semaines puis réduire progressivement en 4 semaines
- Adulte : **0,4 mg/kg/j** pendant 7 jours puis réduire progressivement en 6 à 8 semaines

Diagnostic étiologique et traitement

C. Méningites lymphocytaires hypoglycorachiques

2. Listérienne

- Syndrome méningé et un tableau de rhombencéphalite
- Début progressif
- Atteintes des paires crâniennes
- Hyperleucocytose à PNN
- Evolution favorable sous trt
- Séquelles : troubles de la conscience, atteintes des paires crâniennes
- Traitement : voir cours méningites purulentes

A retenir

- Savoir diagnostiquer une Méningite ou méningoencéphalite
- Identifier les signe de gravité
- Démarche diagnostique étiologique en fonction de la cytologie : Prédominance lymphocytaire ou PNN
et biochimie : Normoglycorachie ou Hypoglycorachie (étiologie bactérienne)
- Etiologies restent parfois inconnues
- Etiologies virales prédominantes
- La tuberculose et la listériose sont les étiologies bactérienne les plus fréquentes en cas de méningites lymphocytaires hypoglycorachiques